Клинические рекомендации

Доброкачественные остео- и хондрогенные опухоли носа и пазух

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D14.0** — Среднего уха, полости носа и придаточных пазух
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.03.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/756_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 4

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 4

3.1 Жалобы и анамнез 5

3.2 Осмотр 5

3.3 Передняя риноскопия и видеориноскопия 5

3.4 Компьютерная томография носа и околоносовых пазух 5

3.5 МРТ и консультации специалистов 6

3.6 Биопсия 6

4. Лечение 6

4.1 Остеома 6

4.2 Фиброзная дисплазия 7

4.3 Другие опухоли 7

4.4 Лучевая терапия 8

4.5 Рецидивы после удаления 8

4.6 Хондрома: другие доступы 8

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 8

5.1 Показания к госпитализации 8

5.2 Реабилитация и наблюдение 8

6. Источник и актуальность 9

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

1. Основные положения

- Доброкачественные костные и хрящевые опухоли носа и околоносовых пазух:
  1. остеома;
  2. остеобластома;
  3. фиброзная дисплазия;
  4. аневризматическая костная киста;
  5. оссифицирующая фиброма;
  6. гигантоклеточная опухоль;
  7. хондрома и другие хрящевые опухоли.

  Наиболее часто встречается остеома лобной пазухи.
- Стойкий или прогрессирующий на фоне лечения односторонний воспалительный процесс в полости носа и пазухах требует исключения опухоли: показаны КТ носа и околоносовых пазух, при необходимости биопсия.
- Диагноз устанавливается на основании жалоб, анамнеза, осмотра, эндоскопии полости носа и КТ носа и околоносовых пазух.
- Лечение хирургическое. При небольшой бессимптомной остеоме допустима выжидательная тактика. После операции выполняется контрольная КТ через **3–6 месяцев**, затем через **1 год и более**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Опухоли

Опухоль	Определение
Остеома	медленно растущая (0,44–6,0 мм в год) опухоль из костной ткани; случаев малигнизации не описано
Остеобластома	редкая опухоль из костной ткани, продуцирующая ретикуло-фиброзные перекладины, окружённые крупными остеобластами
Фиброзная дисплазия	опухолевидное поражение: разрушение костной ткани с деформацией и заполнением костномозгового канала фиброзной тканью
Аневризматическая костная киста	редкое заболевание кости с локальным деструктивным и экспансивным ростом
Оссифицирующая фиброма	опухоль из кальцификатов, цемента, костной и фиброзной ткани; ювенильная форма течёт агрессивнее
Гигантоклеточная опухоль (остеокластома)	редкое новообразование кости с локально-агрессивным, деструктивным ростом
Хондрома	истинная опухоль из хрящевой ткани с длительным развитием: от 3 месяцев до 10 лет
Хондромиксоидная фиброма	редкая опухоль из веретеновидных или звёздчатых клеток в миксоидной или хондроидной строме
Хондробластома	редкая опухоль из хондробластов

Опухоль	Определение
Носовая хондромезенхимальная гамартома	опухоль из веретенообразных клеток, хрящевой ткани и геморрагических кист

2.2 Этиология

Причины окончательно не установлены. Возможные факторы риска — нарушение эмбриогенеза, инфекция, травма; при фиброзной дисплазии основную роль играет мутация гена GNAS1.

2.3 Классификация

Общепринятой классификации нет; классификации отдельных опухолей рабочие и учитываются при планировании лечения.

Рабочие классификации

1. остеома по строению: компактная, губчатая, смешанная;
2. остеобластома по скорости роста: латентная, активная, агрессивная;
3. фиброзная дисплазия: монооссальная (70–85%) и полиоссальная (15–30%);
4. аневризматическая костная киста, фазы: остеолиз, отграничение, восстановление;
5. хондрома: энхондрома (внутри кости) и экхондрома (на поверхности кости).

2.4 Клиническая картина

Жалобы появляются с ростом опухоли — при давлении на стенки пазух и распространении на соседние области; небольшие опухоли бессимптомны и бывают случайной находкой при КТ.

Частые жалобы

1. головная боль в носо-лицевой области, в проекции пазухи;
2. заложенность носа, аносмия — при обтурации соустья, вторичном синусите, мукоцеле;
3. рецидивирующие носовые кровотечения — при аневризматической костной кисте;
4. асимметрия и безболезненный отёк лица — при фиброзной дисплазии;
5. головная боль, нарушение зрения, тригеминальная гиперчувствительность, парез глазных мышц — при гигантоклеточной опухоли клиновидной кости.

Распространение на орбиту и в полость черепа

1. деформация носоглазничной области, проптоз, периорбитальная боль, хемоз, диплопия, периорбитальная эмфизема;
2. слезотечение — при сдавлении носослёзного канала;
3. снижение зрения — при сдавлении зрительного нерва;
4. общемозговые и очаговые симптомы, менингит, абсцесс мозга — при интракраниальном распространении.

---

3. Диагностика

Диагноз — по жалобам, анамнезу, физикальным данным, эндоскопической ревизии полости носа и носоглотки и КТ носа и околоносовых пазух. Симптомы неспецифичны и в начале минимальны; остеома бессимптомна в 4–10% случаев и случайно выявляется при КТ у 1–3% обследованных.

3.1 Жалобы и анамнез

Уточняют

1. сроки, последовательность и динамику жалоб;
2. прежние травмы и заболевания носа и пазух, их лечение и эффект;
3. результаты прежних обследований: анализы, КТ, МРТ, биопсия, протоколы операций;
4. похожие жалобы у близких родственников.

3.2 Осмотр

Общий осмотр, пальпация и перкуссия носо-лицевой области, пальпация подчелюстных, подподбородочных и глубоких шейных лимфоузлов. Для доброкачественных опухолей изменения регионарных лимфоузлов не характерны.

3.3 Передняя риноскопия и видеориноскопия

Показания

1. все пациенты: передняя риноскопия.

Оценивают

1. преддверие носа и передние отделы слизистой оболочки полости носа;
2. нижнюю и среднюю носовые раковины, перегородку носа;
3. наличие и характер отделяемого в носовых ходах;
4. новообразование в передних отделах полости носа или распространяющееся туда из глубоких отделов, обтурирующее полость носа.

Видеориноскопия риноскопом или фиброскопом показана всем пациентам. Первичный осмотр целесообразно выполнять без подготовки полости носа и анестезии.

3.4 Компьютерная томография носа и околоносовых пазух

Показания

1. подозрение на опухоль носа и околоносовых пазух: КТ от плоскости твёрдого нёба до верхней границы лобной пазухи, толщина среза **2 мм**.

Оценивают

1. локализацию, распространённость и размеры новообразования;
2. структуру новообразования;
3. кальцификацию;
4. ремоделирование прилежащей костной ткани.

Остеома на КТ

1. компактная: округлое плотное почти бесструктурное образование;
2. губчатая: грубо-трабекулярная структура;
3. смешанная: зона 300–600 ед. Н губчатого строения и зона более 800 ед. Н компактного вещества.

Фиброзная дисплазия на КТ — однородная ткань «матового стекла» плотностью около 300–450 ед. Н, не инкапсулирована; кистозная форма — с участками более низкой плотности.

Остеобластома на КТ — сочетание плотной кости и участков затемнения.

Хондрома на КТ — образование гетерогенной плотности с чёткими границами и очагами минерализации.

Остеохондрома на КТ — костное вещество неоднородной плотности в центре, ткань хрящевой плотности по периферии.

3.5 МРТ и консультации специалистов

МРТ и консультации челюстно-лицевого хирурга, офтальмолога, нейрохирурга позволяют выявить распространение опухоли на верхнюю челюсть, глазницу и в полость черепа.

Обязательны при

1. изменениях зубочелюстной системы: смещение, расшатывание, выпадение зубов, деформация;
2. глазных симптомах: проптоз, периорбитальная боль, хемоз, диплопия, слезотечение;
3. менингеальных и очаговых неврологических симптомах.

3.6 Биопсия

По показаниям выполняется биопсия и патологоанатомическое исследование с иммуногистохимией для дифференциальной диагностики доброкачественной и злокачественной опухоли.

Способы биопсии

1. прицельная биопсия под эндоскопом: материал берут на границе опухоли с неизменёнными тканями;
2. эксцизионная биопсия: при небольших размерах опухоли;
3. аспирационная биопсия иглой: при кистозном образовании, солидной опухоли;
4. цитологическое исследование отпечатка или мазка-отпечатка со слизистой оболочки: в отдельных случаях.

---

4. Лечение

Лечение хирургическое: эндоназальный, наружный или комбинированный доступ. Применение навигационного оборудования повышает эффективность и безопасность вмешательства.

Экстраназальные доступы при значительной распространённости опухоли

1. транспалатинный;
2. боковая ринотомия;
3. краниофациальная резекция;
4. срединный декортикационный доступ (midfacial degloving).

4.1 Остеома

Эндоназальный (эндоскопический), наружный или комбинированный доступ — по размерам и месту прикрепления. Наружный доступ травматичнее: эстетический дефект, парестезии, прозопалгия.

При небольшой бессимптомной остеоме рекомендуется выжидательная тактика. По некоторым данным, к операции следует прибегать при остеоме, занимающей **более 50%** объёма пазухи. Рецидивы редки и возникают, как правило, через **5–8 лет**.

Классификация остеом лобной пазухи по A. G. Chiu, 2005

Степень	Остеома лобной пазухи
1	прикреплена сзади-снизу, медиальнее плоскости бумажной пластинки; переднезадний размер меньше 75% лобного кармана
2	то же расположение, переднезадний размер больше 75% лобного кармана
3	прикреплена спереди или сверху и (или) выходит латеральнее плоскости бумажной пластинки
4	полностью обтурирует лобную пазуху

Эндоскопическое удаление

1. предпочтительно при остеомах 1 и 2 степени, описано и успешное удаление 3 и 4 степени;
2. относительное ограничение: большие остеомы задне-верхних отделов лобной пазухи (из-за длительности вмешательства);
3. не показано при остеоме на передней и нижней стенке латеральных отделов лобной пазухи;
4. интраорбитальное и интракраниальное распространение не является абсолютным противопоказанием.

4.2 Фиброзная дисплазия

В связи с возможностью регресса рекомендуется выжидательная тактика с постоянным наблюдением и периодической КТ.

Показания к хирургическому лечению

1. выраженная костная деформация;
2. возраст пациента;
3. ограниченная распространённость изменений.

Медикаментозная терапия

1. бифосфонаты: профилактика патологических переломов и боли; существует риск остеонекроза челюсти;
2. при синдроме Мак-Кьюна — Олбрайта: терапия для купирования эндокринных нарушений.

Показания к эндоскопической хирургии

1. облегчение симптомов риносинусита, ассоциированного с фиброзной дисплазией;
2. декомпрессия зрительного нерва.

Эффективность декортикации стенок верхнечелюстной пазухи требует доказательств.

4.3 Другие опухоли

Лечение по виду опухоли

Опухоль	Лечение
Остеобластома	хирургическое удаление эндоназальным, наружным или комбинированным доступом с учётом локализации, размеров и места прикрепления опухоли
Аневризматическая костная киста	хирургическое удаление: от пункции полости кисты до кюретажа и резекции поражённого участка кости; предоперационная эмболизация питающих сосудов
Оссифицирующая фиброма	возможно более раннее и полное удаление: краниофациальная резекция, латеральная ринотомия, midfacial degloving или эндоскопическая диссекция; продолжительное послеоперационное наблюдение
Гигантоклеточная опухоль	хирургическое удаление; длительное динамическое наблюдение
Хондрома	хирургическое удаление из-за риска малигнизации и разрушения стенок: эндоскопически; при распространении в верхнечелюстную пазуху и орбиту — гайморотомия по Денкеру
Хондромиксоидная фиброма	хирургическое удаление; предпочтительна широкая эксцизия эндоскопически или доступом midface degloving
Хондробластома	радикальное иссечение

4.4 Лучевая терапия

1. гигантоклеточная опухоль: может быть рекомендована, если локализация ограничивает радикальное удаление или требует инвалидизирующего вмешательства;
2. аневризматическая костная киста: возможна, но нежелательна из-за риска малигнизации (трансформации в саркому);
3. оссифицирующая фиброма: неэффективна и потенциально опасна из-за вероятности малигнизации.

У остеобластомы описан случай малигнизации после лучевой терапии.

4.5 Рецидивы после удаления

1. остеобластома: после радикального удаления рецидивов нет в течение 5–15 лет; у детей частота рецидивов достигает 32%;
2. аневризматическая костная киста: рецидивы в 10–30% случаев, чаще в течение **первых двух лет**;
3. ювенильная оссифицирующая фиброма: до 30% даже при полном удалении, риск сохраняется до 18 лет;
4. гигантоклеточная опухоль: частота рецидивов зависит от распространённости, данных для носа и пазух нет;
5. хондромиксоидная фиброма: кюретаж эффективен в 80%; многократные рецидивы описаны и после радикальной операции; при иссечении единым блоком рецидивов меньше, но операция травматичнее;
6. хондробластома: при одном кюретаже рецидивы достигают 55%.

4.6 Хондрома: другие доступы

1. радикальное удаление распространённой хондромы может затруднять интраоперационное кровотечение;
2. в некоторых случаях применяют чрезнёбный доступ или боковую ринотомию;
3. хондрому носовых костей удаляют доступом наружной ринопластики.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Госпитализация

1. доброкачественная остео- или хондрогенная опухоль носа и пазух без противопоказаний к плановой операции.

Выписка

1. нет осложнений, удовлетворительное общее состояние.

5.2 Реабилитация и наблюдение

После удаления опухоли рекомендуется охранительный режим **10–14 дней и более**.

Специфической профилактики нет. После операции необходимо динамическое наблюдение: КТ **через 3–6 месяцев**, затем **через 1 год и более**, в зависимости от вида опухоли, локализации и радикальности операции.

Прогноз зависит от гистологии, локализации и распространённости. Радикальное удаление, как правило, приводит к излечению, однако из-за рецидивов и возможной малигнизации необходимо динамическое наблюдение.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Доброкачественные остеогенные и хондрогенные опухоли носа и околоносовых пазух»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 04.03.2023
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее марта 2026 года
Код в рубрикаторе	756_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В критериях оценки качества уровни доказательности (КТ — УУР А, УДД 1; операция — А, 4; охранительный режим — В, 2) не совпадают с уровнями этих рекомендаций в тексте (С, 4–5).